스타틴 부작용, 걱정과 진실 사이

근거로 보는 스타틴 안전성 — 무엇을 걱정하고, 무엇을 안심해도 되는가

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

무엇을 얼마나 걱정해야 하나

별이 많을수록 더 신경 쓸 일입니다 — 진짜 위험은 부작용이 아니라 '안 먹는 것'입니다

걱정거리	걱정할 정도	한 줄 요약
근육통	★★☆☆☆	통증은 진짜지만, 한 시험에서 증상 강도의 약 **90%**는 가짜약을 먹을 때도 똑같이 나타났습니다(노세보)
근육이 녹는 병(횡문근융해증)	★☆☆☆☆	수만 명 중 1명꼴로 아주 드뭅니다. 주로 약물 상호작용·고용량에서 생깁니다
간 수치 상승	★☆☆☆☆	증상 없는 간 수치 상승은 흔하지만, 의미 있는 간 손상은 매우 드뭅니다
새로 생기는 당뇨	★★☆☆☆	상대위험이 약 9% 늘지만, 심근경색·뇌졸중을 막는 이익이 더 큽니다
약물 상호작용	★★★☆☆	일부 스타틴은 특정 약이나 자몽주스와 함께 먹으면 혈중 농도가 오릅니다
약을 안 먹거나 끊는 것	★★★★★	**가장 중요한 위험** — 심근경색 후 끊으면 1년 사망 위험이 **88%** 오릅니다

Tip · 불편한 점이 있으면 끊기 전에 먼저 말씀해 주세요. 대부분 조정으로 해결됩니다.

근거 · EAS 2015 · NLA 2022 · CTT 2022 · Sattar 2010

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근육 증상 — 통증은 진짜, 약 때문은 드뭅니다

실제로 느끼는 근육통과, 약을 모르게 비교했을 때의 진짜 차이는 크게 다릅니다

7–29%	**실제 진료에서 호소하는 비율** 일부 연구는 30%까지 보고합니다.
1–5%	**가짜약과 비교한 진짜 차이** 진짜 약 때문인 경우는 약 0.5%입니다.
15건 중 14건	**스타틴 탓이 아니었던 근육 증상** 대부분은 다른 원인을 약 탓으로 오해한 것입니다.
첫 1년	**진짜 위험이 몰리는 때** 약 때문인 초과 위험은 주로 치료 첫 1년에 있습니다.



Tip · 근육통만 있으면 끊지 말고 먼저 연락 주세요. 콜라색 소변이나 소변량 감소가 보이면 바로 응급실로 가세요.

근거 · EAS 2015 · NLA 2022 · AHA 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

스타틴 탓이라 여긴 근육 증상, 상당 부분은 '약 성분' 때문이 아닙니다

노세보 효과 — 약을 먹는다는 생각만으로도 같은 증상이 생깁니다

증상 점수로 비교한 시험 결과

90%

스타틴 때문이라 여긴 근육 증상의 강도 가운데 가짜약을 먹을 때도 나타난 몫

어떻게 시험했나

한 사람이 진짜 약과 가짜약을 **어느 쪽인지 모르는 채** 번갈아 먹으며 근육 증상을 기록했습니다.

결과

진짜 약을 먹을 때와 가짜약을 먹을 때의 근육 증상 차이는 **통계적으로 의미 없을 만큼** 작았습니다.

그 뒤

'스타틴이 안 맞는다'며 끊었던 분의 **약 절반**이 이 시험 뒤 다시 복용에 성공했습니다.

Tip · 근육통이 '가짜'라는 뜻이 아닙니다. 통증은 진짜이고, 원인이 약 성분이 아닌 경우가 많다는 뜻입니다.

근거 · SAMSON 2020 · StatinWISE 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

근육 증상이 있으면 — 즉시 중단이 아니라 단계적 재평가

근육 증상이 생겼을 때 진료실에서 밟는 네 단계입니다

1

시간 관계 확인

복용을 시작하고 비교적 이른 시기에 생겼는지, 끊으면 나아지는지 봅니다.

2

다른 원인 확인

운동, 갑상선 기능 저하, 비타민D 부족, 함께 먹는 약을 점검합니다.

3

다시 시작해 보기

잠시 쉬었다가 같은 약이나 다른 스타틴을 적은 용량으로, 또는 주 1~3회로 다시 시작합니다.

4

약 바꾸기·더하기

그래도 어려우면 에제티미브나 주사형 약(PCSK9 억제제)을 더합니다.

바로 끊지 마세요

대부분 용량 조정이나 약 바꾸기로 다시 잘 드실 수 있습니다. 진료실에서 이 순서로 함께 확인합니다.

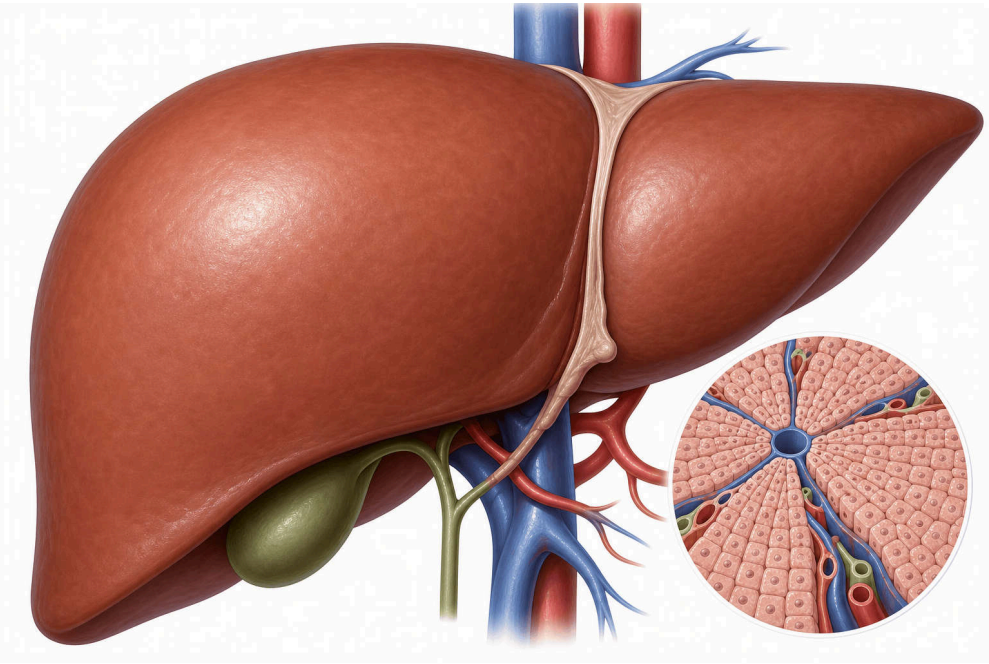
Tip · 증상이 언제 시작됐는지, 새로 먹기 시작한 약이 있는지 적어 오시면 도움이 됩니다.

근거 · 2018 ACC/AHA 콜레스테롤 지침 · EAS 2015

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

간 수치 — 정기 간검사는 더 이상 필요 없습니다

증상 없는 간 수치 상승은 흔하지만, 의미 있는 간 손상은 매우 드뭅니다 · 달력에 정기 간검사 날짜를 적어 둘 필요는 없습니다



0.5–3%

증상 없는 간 수치 상승

주로 첫 3개월에 나타나고, 약 70%는 계속 먹어도 사라집니다.

1/17,000

의미 있는 간 손상

1만 7천 명 중 1명꼴로 매우 드뭅니다.

1회

시작 전 간 검사

2012년 미국 FDA가 정기 간검사 권고를 없앴습니다. 그 뒤로는 증상이 있을 때만 봅니다.

① 약은 매일 꾸준히

② 정기 간검사 날짜는 따로 없음

③ 간 수치는 증상이 있을 때만 — LDL(약효) 피검사는 4~12주 뒤 따로 합니다

Tip · 피곤함이 심하거나 소변 색이 짙어지는 등 몸이 이상하면, 다음 진료를 기다리지 말고 연락 주세요. 지방간이 있어도 안전하고 오히려 간 수치가 좋아집니다. 활동성 간질환·비대상성 간경변만 금기입니다.

근거 · FDA 2012 · Björnsson 2012 · AASLD

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

당뇨가 약간 늘 수 있지만, 이익이 훨씬 큽니다

새로 생기는 당뇨 — 위험은 작고, 심장·혈관을 지키는 이익은 분명합니다

새로 생길 수 있는 당뇨

위험은 **작습니다**.

- 상대위험이 약 **9%** 늘어납니다 — 13개 연구, 9만여 명
- 4년 동안 먹으면 **255명당 1명**꼴로 당뇨가 더 생깁니다
- 고용량일수록, 당뇨 전단계일수록 조금 더 오릅니다

vs

막아 주는 심근경색·뇌졸중

이익이 **훨씬 큽니다**.

- 당뇨 고위험군에서 당뇨가 54건 느는 동안 심혈관 사건·사망 **134건**을 막았습니다
- 당뇨가 생겨도 스타틴의 심혈관 이익은 **그대로**입니다
- 당뇨 위험 요인이 있으면 혈당도 함께 챙깁니다

Tip · 당뇨 전단계라는 말을 들은 적이 있으면 알려 주세요. 혈당 검사를 함께 챙깁니다.

근거 · Sattar 2010 · Preiss 2011 · JUPITER 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

약물 상호작용 — 알면 대부분 안전하게 관리됩니다

스타틴 종류에 따라 영향이 다릅니다 — 새 약을 시작하면 미리 알려 주세요

구분	내용
농도가 오르기 쉬운 스타틴	**심바스타틴 · 로바스타틴** — 아토르바스타틴은 일부만 영향을 받아 덜합니다
영향이 적은 스타틴	로수바스타틴 · 프라바스타틴 · 피타바스타틴 · 플루바스타틴 단, 산디문(사이클로스포린)을 드시면 로수바·피타바스타틴도 제한 — 산디문 안내문
조심할 음식	자몽주스 — 심바스타틴 농도가 **3~4배** 오릅니다
조심할 약	곰팡이 약(이트라코나졸 등) · 클래리스로마이신 항생제 · 베라파밀 · 딜티아젬 · 사이클로스포린 HIV 약 — 심바·로바스타틴과는 **함께 쓰지 않습니다**
비교적 안심	항생제는 아지스로마이신 · 중성지방 약은 페노피브레이트
아시아인	로수바스타틴 혈중 농도가 약 **2배** — **5mg** 저용량부터 시작합니다

Tip · 다른 병원에서 새 약을 받으면 '스타틴을 먹고 있다'고 꼭 말씀해 주세요.

근거 · 2016 AHA 약물상호작용 성명 · FDA 로수바스타틴 라벨(2023)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진짜 위험은 부작용이 아니라 '안 먹는 것'입니다

지금까지는 부작용 이야기였습니다 — 막아 주는 쪽의 숫자를 보세요

21%↓

주요 혈관 사건

나쁜 콜레스테롤(LDL)을 약 39 mg/dL 낮추면 약 1/5 줄고, 낮출수록 더 줄어듭니다.

48건↓

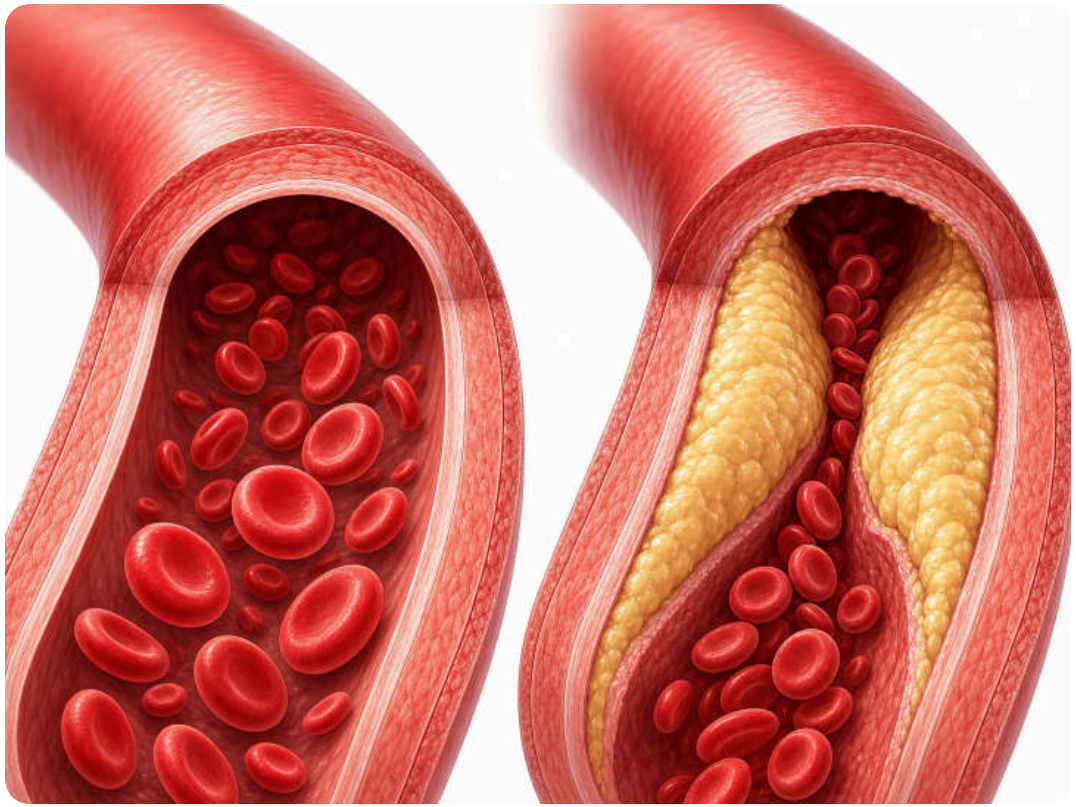
이미 관상동맥질환이 있는 분

1,000명당 48건을 막아 이익이 가장 큽니다.

88%↑

심근경색 후 끊었을 때

1년 사망 위험이 거의 2배가 됩니다.



Tip · 부작용은 대부분 되돌릴 수 있지만, 한번 생긴 심근경색·뇌졸중은 되돌릴 수 없습니다.

근거 · CTT 2010 · Daskalopoulou 2008 · 2018 ACC/AHA

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

흔한 오해 바로잡기

자주 듣는 걱정 네 가지 — 사실은 이렇습니다

오해 1

"간 수치 때문에 검사를 계속해야 한다"

사실 — 2012년부터 정기 간검사는 필요 없습니다. 시작 전 1회, 그다음은 증상이 있거나 필요할 때만.

오해 2

"당뇨를 일으키니 위험하다"

사실 — 위험은 작고(4년에 255명당 1명), 심혈관 이익이 훨씬 큽니다. 당뇨가 생겨도 이익은 그대로입니다.

오해 3

"지방간이면 스타틴 금지"

사실 — 지방간에서는 오히려 이롭습니다. 활동성 간질환·비대상성 간경변만 금기입니다.

오해 4

"평생 먹어야 하니 부담이다"

사실 — 끊는 위험(심근경색 후 1년 사망 88%↑)이 훨씬 큽니다. 불편하면 끊지 말고 함께 조정합니다.

Tip · 인터넷에서 본 걱정이 있으면 진료 때 그대로 물어봐 주세요.

근거 · FDA 2012 · JUPITER 2012 · AASLD · Daskalopoulou 2008

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

환자분이 기억할 7가지

스타틴을 안전하게, 그리고 끝까지 잘 드시기 위한 실천 항목

01 근육통·불편함이 있어도 **스스로 끊지 말고** 먼저 연락 주세요

02 새 증상이 복용 시작과 시기가 맞는지, 끊으면 나아지는지 함께 봅니다

03 간·근육 검사는 **시작 전 1회**, 그리고 증상이 있을 때만 — LDL(약효) 피검사는 4~12주 뒤 따로 합니다

04 자몽주스·새 항생제·곰팡이 약을 시작하면 **미리 알려** 주세요

05 당뇨 위험 요인이 있으면 알려 주세요 — 혈당도 함께 챙깁니다

06 식사·운동·금연으로 약 효과를 더 키우세요

07 임의로 끊으면 심근경색·뇌졸중 위험이 커집니다 — **조정은 함께**

불편하면 끊지 마시고, 같이 방법을 찾겠습니다

용량을 줄이거나, 다른 스타틴으로 바꾸거나, 다른 약을 더하는 방법이 있습니다.

Tip · 이 장을 사진으로 찍어 두시면 다음 진료 때 확인하기 좋습니다.

근거 · 2018 ACC/AHA · KSoLA 2022 이상지질혈증 진료지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

부작용은 되돌릴 수 있지만, 심근경색은 되돌릴 수 없습니다

불편한 점이 생기면 끊지 마시고 언제든 말씀해 주세요 — 함께 조정하겠습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

부작용 걱정을 근거로 정리한 설명자료입니다. 약 조정은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

SAMSON 2020 · StatinWISE 2021 · CTT 2010·2022 · Sattar 2010 · Preiss 2011 · JUPITER 2012 · FDA 2012 · Björnsson 2012 · EAS 2015 · NLA 2022 · 2018 ACC/AHA · KSoLA 2022 · Daskalopoulou 2008

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

Tip · QR로 다시 보기 · 집에서 볼 확인 일정과 대처표는 스타틴 안내문을 드립니다.